Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Ivoti

Rua Bento Gonçalves, 800 - Bairro: Centro - CEP: 93900000 - Fone: (51) 3098 5193 - Balcão Virtual: (51) 99605-6365 - Email: frivoti1vjud@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5000505-57.2025.8.21.0166/RS

AUTOR: SANDRA ARAUJO CARDOSO DE LIMA

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

SANDRA ARAUJO CARDOSO DE LIMA ajuizou a presente Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, ambos já qualificados nos autos. Narra a autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré (Plano Ideal, Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia) e que, em 2019, foi diagnosticada com neoplasia de mama (CID C50.9), com metástase para o fígado e linfonodos. Relata que, após progressão da doença mesmo com tratamentos anteriores, seu médico assistente prescreveu o uso combinado dos fármacos **Fulvestranto** e **Capivasertibe (Truqap®)**, destacando a urgência da medida em razão do risco de morte. Aduz que a ré, embora tenha autorizado o fornecimento do Fulvestranto, negou a cobertura para o Capivasertibe, sob a justificativa de que o tratamento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta a ilegalidade da negativa e requer, liminarmente, que a ré seja compelida a custear o tratamento prescrito. Ao final, pugna pela confirmação da tutela e procedência do pedido (evento 1, INIC1).

Inicialmente, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça (evento 3, DESPADEC1), decisão que foi mantida após pedido de reconsideração (evento 7, DESPADEC1). A autora interpôs Agravo de Instrumento, ao qual foi dado provimento para conceder o benefício (evento 15, ANEXO2).

A análise do pedido liminar foi postergada para após a contestação. Contudo, em reanálise, a tutela de urgência foi deferida para determinar que a ré fornecesse os medicamentos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de bloqueio de valores (evento 16, DESPADEC1).

Citada (evento 35, PRECATORIA2), a ré apresentou contestação (evento 40, CONT1). Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No mérito, defendeu a legalidade da negativa, argumentando que o tratamento não atende às Diretrizes de Utilização Técnica (DUT) previstas no Rol da ANS, o qual possui natureza taxativa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e disposições da Lei nº 14.454/2022. Sustentou a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e pugnou pela total improcedência da ação.

Houve réplica (evento 44, RÉPLICA1).

Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (evento 46, TERMOAUD1).

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (evento 52, DESPADEC1), a parte ré manifestou desinteresse em dilação probatória e requereu o julgamento antecipado do feito (evento 60, PET1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 Da Preliminar: Impugnação ao Valor da Causa

A ré impugna o valor atribuído à causa pela autora (R$ 613.065,24), sustentando que deveria ser fixado o valor de alçada.

Sem razão a demandada.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte. Na presente ação, o objeto é a obrigação de fornecer tratamento de uso contínuo e por tempo indeterminado. A estimativa apresentada pela autora, correspondente ao custo do tratamento por doze meses, mostra-se razoável e atende ao disposto no artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece que, em ações com prestações sucessivas, o valor da causa corresponderá à soma de doze prestações mensais.

Assim, rejeito a preliminar.

II.2 Do mérito

Inexistindo mais preliminares, bem como tendo o feito observado regular tramitação, **passo ao exame do mérito**.

Trata-se de ação através da qual a autora, beneficiária de plano de saúde da parte demandada, pretende a condenação desta ao fornecimento do medicamento Capivasertibe (Truquap), enquanto perdurar a necessidade.

Nessa linha, inegável a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, disposições que devem ser aplicadas em conjunto com o regramento especial dos planos de saúde (Lei n° 9.656/98).

O autor é cliente dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se no conceito de consumidor, nos moldes do artigo 2.º da Lei nº 8.078/90. A parte ré, por seu turno, na condição de prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3.º, do mesmo diploma legal.

Aliás, tal questão restou sedimentada, a partir da edição da Súmula 608/STJ, que assim dirimiu a controvérsia:

> *"Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".*

Os laudos médicos acostados aos autos (evento 1, LAUDO8 e evento 1, LAUDO9), são claros ao descrever a gravidade do quadro clínico da autora, que já se submeteu a outras linhas de tratamento sem o sucesso esperado, apresentando progressão da doença com metástase hepática e risco iminente de morte. O profissional que a assiste indicou, de forma fundamentada, a necessidade e a urgência do tratamento combinado com Fulvestranto e Capivasertibe.

Cinge-se a **controvérsia** quanto à legalidade da negativa da parte requerida em realizar a cobertura do respectivo tratamento. No ponto, a negativa da ré teve como fundamento o não cumprimento da DUT nº 64 do Rol da ANS.

O enunciado nº 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação entre as partes: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*". Em razão disso, de fato as disposições contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, CDC.

Destaco que os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não lhes cabe limitar o tipo de tratamento prescrito, a quantidade de consultas e materiais necessários ou, ainda, o modo de sua prestação, prerrogativas que são dos profissionais que tratam do paciente.

Nesse sentido, o TJ/RS:

> *APELAÇÕES CIVEIS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. PRESCRIÇÃO DE USO EM AMBIENTE DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. CASO CONCRETO. 1. Os planos de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de interpretação literal e mais benéfica ao aderente. 2. Reconhecido que o contrato entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura os medicamentos correlatos. 3.* ***O plano de saúde não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado, especialmente em se tratando de fármaco antineoplásico ministrado para ambiente domiciliar.*** *4. O descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo ao reconhecimento de danos extrapatrimoniais. Hipótese em que a negativa decorreu de razoável interpretação de cláusula contratual. 5. Honorários advocatícios. Manutenção do percentual fixado na origem, ainda que abaixo do mínimo legal previsto no artigo 85, §2º do CPC, em razão do elevado valor atribuído à causa, do trabalho despendido pelos patronos e do deslinde célere da controvérsia. APELO DA RÉ DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 70083655183, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 07-08-2020)*

Há também precedentes no sentido de que os planos de saúde não podem recusar cobertura de tratamento em relação à doença coberta pelo plano sob o argumento de que o tratamento não consta na lista da ANS. Isso porque a lista de terapias indicada pela ANS apresenta rol exemplificativo, não exaustivo:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. IMPLANTE DE DESFIBRILADOR INTERNO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS MÉDICAS NO VALOR DE R$ 57.928,00, REFERENTES AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE DESFIBRILADOR INTERNO, PLACAS E ELETRODOS, REALIZADO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA PELA AUTORA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE; (II) O DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS SUPORTADAS PELA BENEFICIÁRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. OS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME SÚMULA 608 DO STJ, DEVENDO SUAS CLÁUSULAS SEREM INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.2. OS PLANOS DE SAÚDE PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, MAS NÃO LHES CABE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO PRESCRITO, INCUMBÊNCIA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE.3.* ***O ROL DA ANS POSSUI NATUREZA EXEMPLIFICATIVA, REPRESENTANDO UM PARÂMETRO MÍNIMO DE COBERTURA, NÃO SENDO TAXATIVO, CONFORME § 12 DO ART. 10 DA LEI N. 9.656/98, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.454/2022.4. O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA, POIS A TÉCNICA NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO FICA A CRITÉRIO DO MÉDICO ASSISTENTE, DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADES DO CASO.*** *5. O PLANO DE SAÚDE QUE NEGA INDEVIDAMENTE COBERTURA CONTRATUAL, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU DIANTE DE PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA, DEVE REEMBOLSAR INTEGRALMENTE OS VALORES PAGOS PELO BENEFICIÁRIO.6. NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO, DECLARADOS EM R$ 7.000,00, O REEMBOLSO DESTE VALOR ESPECÍFICO NÃO PODE SER RECONHECIDO, SOB RISCO DE SE ADMITIR CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR DO REEMBOLSO O VALOR DE R$ 7.000,00 REFERENTE AOS HONORÁRIOS DO CIRURGIÃO, NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS.2. CONDENAÇÃO DA OPERADORA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, §11º, DO CPC.TESE DE JULGAMENTO: 1.* ***A NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE É ABUSIVA, AINDA QUE NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS, O QUAL CONSTITUI APENAS REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURA, NÃO SENDO TAXATIVO.*** *PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. (Apelação Cível, Nº 50019214820238210128, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 31-10-2025) (grifei)*

De outra parte, conforme o art. 6º da Constituição Federal, são "*direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição*".

No presente caso, a médica assistente justifica a especificação dos fármacos por ser recomendado por estudos clínicos que a combinação dos fármacos demonstram benefício clínico de sobrevida, sendo que a utilização de somente um deles pode impor maior risco de vida ao paciente (evento 1, LAUDO8). Veja-se:

Laudo Médico para Solicitação de Tra+amento Anti-neoplásico

Solicito autorização para tratamento da sra. Sandra Araújo Cardoso de Lima, 56 anos. Apresenta diagnóstico de carcinoma invasor de mama com metástases hepáticas, presença de receptores hormonais positivos e HER-2 negativo. **Mutação PIK3CA detectada**.

Já realizou linha de hormonioterapia prévia e quimioterapia com docetaxel e gencitabina.

Solicitado tratamento com **Fulvestranto, 500 mg D1, D15 (primeiro ciclo, após a cada 28 dias)** e **Capivasertibe (Truqap®** , 400 mg, 12/12h, via oral, nos quatro primeiros dias de cada semana (8 cps ao dia, 64 cps a cada 28 dias). Paciente até o momento obteve autorização somente para Fulvestranto, ficando deprivada do benefício da combinação mais efetiva, desta forma.

Apresenta indicação deste tratamento **combinado** por apresentar a mutação PIK3CA e estar com doença em progressão, correndo risco de morte em decorrência da gravidade de sua doença. Por tratar-se de doença visceral (metástase hepática) e agressiva, necessita de tratamento com urgência. Estudos clínicos (disponível referência abaixo) demonstram benefício clínico em termos de sobrevida para estas pacientes quando tratadas com esta combinação. Somente o uso de fulvestranto impõe risco maior à vida da paciente.

Atenciosamente,

Daniela Lessa da Silva
Oncologista Clínica
CRM 23039

Dra Daniela Lessa da Silva
Oncologista Clínica CREMERS 23039
Novo Hamburgo, 06 de janeiro de 2024.

Referência:
N Engl J Med 2023;388:2058-2070

Em resposta à solicitação administrativa de fornecimento do fármaco, a parte ré indeferiu o pedido sob a alegação de que o medicamento não está contemplado no rolda ANS, de forma que não há cobertura pelo referido plano (evento 1, CERTNEG18):

SulAmérica

Solicitação de Validação Prévia de Procedimentos (VPP)

CN 001 - Nao Consta No Rol - #

São Paulo, 06/02/2025

Segurado(a): SANDRA ARAUJO CARDOSO
Cód. de Identificação: 88888460243030015
Nº da guia: 188067286

Ref: Pedido de Validação Prévia de Procedimentos

Prezado Prestador/Segurado(a),

Em atenção à sua solicitação de Validação Prévia de Procedimentos para TRUQAP, gostaríamos de prestar os seguintes esclarecimentos:

Após análise técnica detalhada do seu pedido, constatamos que não é possível emitir validação para o procedimento solicitado, uma vez que o referido procedimento não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, resultando na ausência de sua cobertura. Lembramos que tal condição é respaldada pela Cláusula Contratual de Cobertura.

Para obter mais informações, o(a) beneficiário(a) pode entrar em contato com a nossa Central de Atendimento 24 (vinte e quatro) horas por meio do telefone que está no verso do cartão de identificação. Em caso de solicitação de reanálise, recomendamos contatar um dos canais de atendimento da Ouvidoria, no prazo máximo de 2(dois) dias úteis.

Atenciosamente,

SulAmérica

A parte ré, todavia, não se desincumbiu do seu ônus probatório, mediante a comprovação técnico-científica de que o medicamento indicado não é recomendado para tratamento da moléstia que acomete o autor, limitando-se a reiterar a tese de ausência do dever de cobertura por se tratar de uso *off label*.

Dessa forma, limitar a cobertura ao estritamente previsto no Rol, ignorando a prescrição do profissional que detém o conhecimento técnico sobre a condição do paciente, representa uma interferência indevida na prática médica e esvazia o próprio objeto do contrato, que é a garantia da assistência à saúde. A recusa da ré, portanto, mostra-se abusiva.

Assim, havendo expressa indicação médica para o tratamento, justificada pela gravidade e urgência do quadro clínico, a recusa da operadora de saúde em fornecer o medicamento prescrito é ilegítima e afronta a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

O direito à vida e à saúde, constitucionalmente assegurado, prevalece sobre interesses meramente patrimoniais e sobre as limitações administrativas impostas por meio de resoluções. A confirmação da tutela de urgência deferida é, portanto, medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **SANDRA ARAUJO CARDOSO DE LIMA** em face de **SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE**, para, confirmando a tutela de urgência deferida no evento 16, DESPADEC1, condenar a ré a fornecer e custear, de forma contínua e por tempo indeterminado, o tratamento com o medicamento **Capivasertibe (Truquap®)**, nas dosagens e periodicidade prescritas pelo médico assistente, enquanto perdurar a necessidade clínica.

Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, os quais fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º do CPC).

Sentença publicada e registrada eletronicamente.

Intimação agendada.

Em face da sistemática do Código de Processo Civil, notadamente no que tange à inexistência de admissibilidade no juízo *a quo* (art. 1.010, § 3º, do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Transitada em julgado a presente decisão, baixe-se.

Diligências legais.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO LAUX JUNIOR, Juiz de Direito**, em 26/11/2025, às 10:22:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10095464488v22** e o código CRC **96b37190**.